

ORIENTACIONES PARA EL AUTOCUIDADO DE LA DIABETES

MÓDULO 01: CUIDADO DE LOS PIES



OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ORIENTACIONES PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES

Módulo 01: Cuidado de los pies

OPS/NMH/NV/23-0041

© **Organización Panamericana de la Salud, 2023**. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Créditos:

Ilustraciones de @freepik / felicities y adaptadas por @dixiart

LA DIABETES Y LOS PIES

01 Introducción

Este documento, que describe un elemento clave en el cuidado de la diabetes, está dirigido a las personas con la enfermedad, a sus familias y a sus cuidadores.

Su propósito es contribuir al automanejo de la diabetes, por lo que se facilitan algunas recomendaciones básicas para prevenir la aparición de lesiones en los pies. No reemplazan las indicaciones del médico o del equipo de salud, pero pueden servir de ayuda para prevenir una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes.



En este documento
ENCONTRARÁ

¿Por qué la diabetes afecta a los pies?

La presencia de heridas es grave y frecuente y ¡es una urgencia!

¿Cómo cuidarse los pies cada día?

¡Cuidarse los pies es una prioridad!

¿Cómo prevenir el daño?

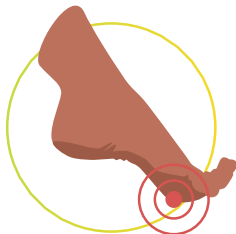
Algunos recursos disponibles para obtener más información

Los problemas en los pies son frecuentes en las personas con diabetes. Esto se debe a que un nivel elevado de azúcar en la sangre (hiperglucemia) mantenido durante un largo período de tiempo puede dañar los nervios, especialmente de las piernas y de los pies (neuropatía periférica diabética) y la circulación de la sangre.

Otros factores que pueden
AUMENTAR EL RIESGO
de que una persona con diabetes
tenga una lesión en los pies son



Nivel de azúcar
en sangre mal
controlado



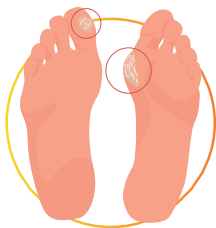
Neuropatía
periférica diabética
(daño en los
nervios de los pies)



Enfermedad arterial
periférica (daño en
la circulación de las
extremidades inferiores)



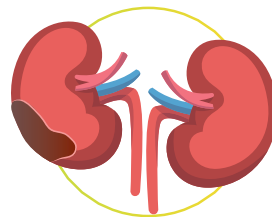
Deformidades en el
pie: juanetes, dedos
en martillo o dedos en
garra y otros



Durezas y
callosidades



Lesiones o
amputaciones
previas



Enfermedad del riñón por
la diabetes, en especial en
las personas en diálisis o
receptoras de un trasplante
renal



Fumar

La neuropatía periférica diabética ocasiona que el pie esté insensible y a veces, también deforme.

Debido a ello puede que usted apoye el pie de una forma incorrecta o que tenga dificultad para caminar. Como las personas que tienen neuropatía periférica diabética pierden la sensibilidad al dolor, al calor y al frío, es posible que no se den cuenta cuando sufren heridas, quemaduras u otras lesiones en sus pies y por ello, demoren en consultar.

La presencia de heridas es grave y frecuente y ¡es una urgencia!

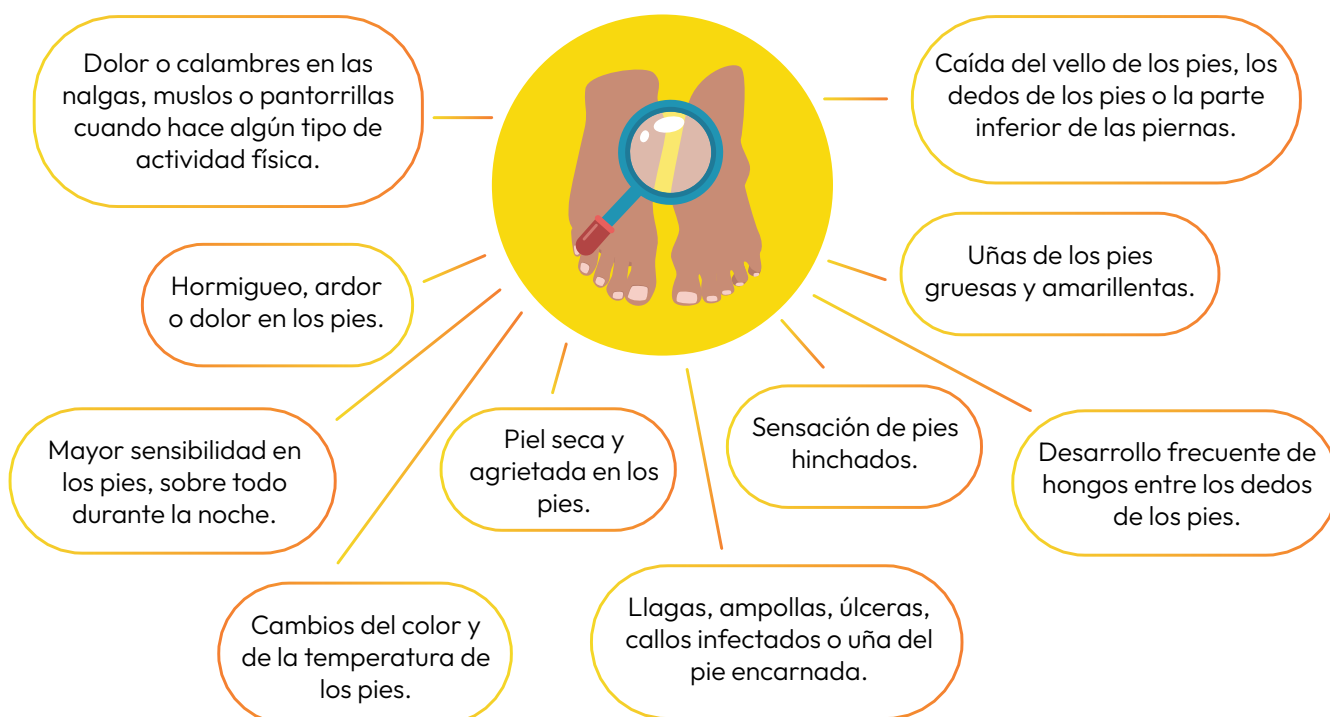
Se debe acudir a la consulta del médico e **iniciar el tratamiento lo antes posible**, ya que, debido al daño en los vasos sanguíneos, las heridas cicatrizan muy lentamente y se infectan con facilidad. **Las consecuencias son tan graves que pueden llevar a la amputación.**

Muchas personas con neuropatía periférica diabética no tienen síntomas. Esto es un factor de riesgo, ya que, al no sentir el dolor, aumenta la probabilidad de sufrir lesiones, úlceras y amputaciones.

Acuda regularmente a su médico y pídale que le examine los pies para descartar cualquier complicación.



Cuando hay neuropatía periférica diabética, **PUEDEN APARECER OTROS SÍNTOMAS** que requieren consultar con el médico, tales como



ÚLCERA DEL PIE DIABÉTICO

La úlcera del pie diabético (o úlcera diabética del pie) es una complicación grave, frecuente y una de las principales causas de muerte en las personas con diabetes.

Se trata de una **herida localizada en cualquier parte del pie o del tobillo** producida generalmente por usar un calzado inapropiado o por caminar descalzo (recordemos que la diabetes provoca pérdida de la sensibilidad al dolor, al calor y al frío). Como la piel se rompe, pierde su función protectora y permite que la úlcera se infecte. A veces, el daño puede ser tan grave que requiera la amputación de un dedo del pie, del pie entero o de la pierna.

Una de las mejores maneras de disminuir el riesgo de úlcera en el pie y, por ello, de amputación es **reconocer a tiempo cualquier lesión y recibir tratamiento adecuado enseguida**.

Las úlceras en el pie son una urgencia y pueden poner en riesgo la vida:
se debe consultar cuanto antes al médico.

Para
EVITAR PROBLEMAS GRAVES
en los pies, es recomendable que usted



Revise los pies todos los días, mediante la observación del dorso, de la planta y de los espacios entre los dedos. Busque cortes, rasguños, ampollas, enrojecimiento, hinchazón o problemas de las uñas. Utilice un espejo de mano con aumento para revisar la planta de los pies.

Si tiene dificultad para revisarse los pies (problemas de movimiento o de visión), **pida a otra persona que le ayude** a hacerlo.

Lávese los pies con agua tibia, nunca caliente. Compruebe la temperatura del agua con el codo o con la muñeca. Hágalo a diario para mantenerlos limpios.

Lávese los pies con delicadeza: **láveselos con una toalla suave o con una esponja.** Para secarlos, deje que la toalla absorba el agua o dé golpecitos suaves con ella y seque cuidadosamente entre los dedos.

Después de lavarse y secarse los pies, **aplíquese una crema hidratante** para evitar que la piel seca ocasione comezón o se agriete.

Córtese las uñas con cuidado en un lugar bien iluminado. Idealmente, deje que lo haga un podólogo con experiencia en atender a personas con diabetes. Si lo debe hacer usted, córtelas en línea recta y lime el borde, de preferencia con una lima de cartón.



No use jabones desinfectantes, ya que eliminan la protección natural de la piel.

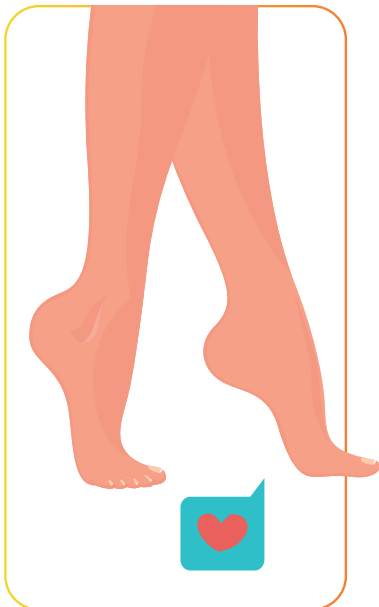
No remoje los pies, para evitar la maceración de la piel.

No se aplique crema hidratante entre los dedos, pues podría causar una infección por hongos.

No se corte las uñas demasiado, ya que eso puede hacer que la uña se encarne. Si no ve bien, deje que otra persona se las corte. Si tiene alguna inquietud sobre sus uñas, consulte a su médico.

Nunca se corte los callos ni las callosidades usted mismo. No use almohadillas medicinales. Acuda a su médico para recibir el tratamiento apropiado.

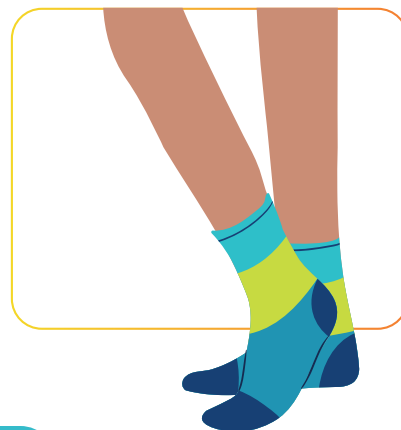
PROTÉJASE LOS PIES



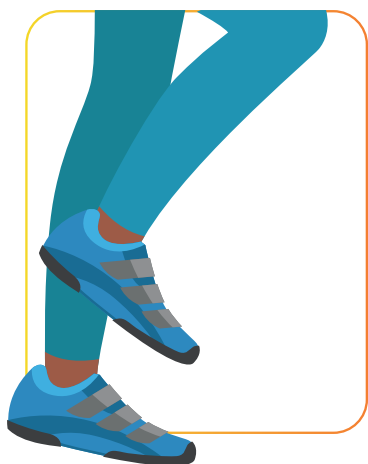
- No use “removedores de callos” ni lijas metálicas ni piedra pómez.
- Mantenga los pies abrigados y secos.
- No utilice calentadores ni bolsas de agua caliente para calentar los pies.
- Nunca camine descalzo o solo con calcetines, ni siquiera en casa. Use siempre zapatos, zapatillas o pantuflas, puesto que podría pisar algo que lo lastime o le produzca un corte.
- Si usted debe permanecer en cama por alguna enfermedad o está postrado, consulte con su equipo médico las medidas de protección temporales para evitar heridas en los talones.
- Hágase revisar los pies regularmente por un profesional con experiencia en el cuidado del pie diabético.

LAS MEDIAS Y LOS CALCETINES

- Cámbiese de calcetines todos los días. Lávelos del revés.
- Use los zapatos con calcetines o medias de algodón, claras y sin costuras. Si esto último no es posible, póngase los calcetines del revés, con las costuras hacia afuera.
- Asegúrese de que los calcetines o medias tengan elásticos suaves para permitir una buena circulación sanguínea.



EL CALZADO



- Antes de ponerse los zapatos, sacúdalos y tóquelos por dentro. Recuerde que sus pies pueden no sentir una piedra o algún otro objeto en el zapato, así que inspecciónelos siempre antes de ponérselos.
- Use los calcetines y el calzado apropiados. El interior del zapato debe ser de 1 a 2 centímetros (de 0,4 a 0,8 pulgadas) más largo que el pie y no debe quedar ni demasiado ajustado ni demasiado suelto.
- Use zapatos de punta redondeada, que le permitan mover cómodamente los dedos.
- Evite el uso de sandalias abiertas.
- Compre los zapatos a última hora del día (cuando puede tener el pie hinchado) y pruébeselos de pie para comprobar que se le ajustan de manera adecuada.
- Ablande de forma gradual los zapatos nuevos, usándolos de una a dos horas diarias.
- Si usted tiene alguna deformidad en el pie o callos o lesiones previas, consulte con su médico la necesidad de usar calzado terapéutico. Este tipo de calzado puede ser más profundo, y tanto calzado como plantillas pueden estar hechos a medida.
- Nunca vuelva a usar los mismos zapatos que le hayan causado una úlcera o herida en los pies.



Un **SÍ** a cualquiera de estas preguntas
PUEDE SER UNA URGENCIA

¿Ha observado
cambio de
coloración en la
piel de los pies?

¿Ha perdido
sensibilidad en
los pies?

¿Ha sentido dolor
en las piernas
o en los pies
últimamente?

¿Ha observado
cambios en la
forma de los pies?

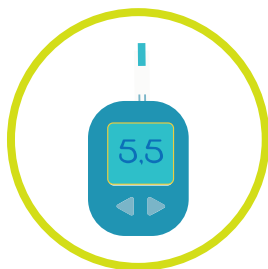
¿Tiene heridas o
rasguños en los
pies?

¿Tiene alguna
uña encarnada
en los dedos de
los pies?

¿Tiene picazón
o grietas entre
los dedos o en la
planta de los pies?



Si observa alguno de estos cambios en los pies, consulte de inmediato en su centro de salud, sin esperar cita con el médico o consulte en el servicio de urgencias.



Cuide su diabetes.
Mantenga bajo control el nivel de azúcar en la sangre.



No fume. Fumar disminuye la circulación de la sangre a los pies.



No use bolsas de agua caliente ni ponga los pies cerca de estufas.



No camine descalzo, ni siquiera en verano.



Haga ejercicios específicos para los pies, 10 minutos al día. Por ejemplo: a) mover en círculos el tobillo, primero hacia un lado y luego hacia el otro, b) mover el tobillo hacia arriba y hacia abajo, y c) abrir y cerrar los dedos de los pies.

Las demás medidas de autocuidado, como **seguir una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, bajar de peso en caso de tener sobrepeso u obesidad o controlar la presión arterial** son también importantes en el cuidado de los pies.



Recuerde que cualquier lesión en los pies, como cambios en el color de la piel, hongos entre los dedos de los pies o una herida, aunque sea pequeña, debe controlarse inmediatamente. No espere hasta la cita de control y acuda al centro de salud para que lo evalúe su equipo médico.



Para obtener más información sobre el cuidado de los pies en personas con diabetes visite los enlaces a las siguientes publicaciones:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La diabetes y los pies. Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, División de Diabetes Aplicada. Atlanta: CDC; 2022. Disponible en: <https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/living/healthy-feet.html>.

International Diabetes Federation (IDF). Clinical practice recommendation on the diabetic foot: A guide for health care professionals. Bruselas: International Diabetes Federation; 2017. Disponible en: <https://idf.org/about-diabetes/resources/?type=276>.

International Working Group on the Diabetic Foot. Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease. IWGDF 2023 update. [s.l.]: IWGDF; 2023. Disponible en: <https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2023/07/IWGDF-2023-01-Practical-Guidelines.pdf>.

Organización Panamericana de la Salud. Diagnóstico y manejo de la diabetes de tipo 2 (HEARTS-D). Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/diagnostico-manejo-diabetes-tipo-2-hearts-d>.

ORIENTACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS PIES EN LAS PERSONAS CON DIABETES

Este documento describe un elemento clave en el cuidado de la diabetes. Está dirigido a las personas con la enfermedad, sus familias y sus cuidadores. Tiene como propósito contribuir al automanejo de la diabetes entregando algunas orientaciones básicas para prevenir la aparición de lesiones en los pies.

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas